Module 3 : Reconnaissance et soutien aux PA

Cours 7 : Services sociaux et de santé destinés aux PPA

Objectifs :

- Examiner l'évolution de la place de l'État dans les services destinés aux personnes présentant des besoins de soutien.
- Identifier les services spécifiques mis en place au Québec pour venir en aide aux personnes proches aidants.
- Connaître les différents prestataires de services de soutien à domicile.
- Identifier les services spécifiques mis en place au Québec pour venir en aide aux personnes nécessitant du soutien à domicile.

PPT narré :

- 1x (26 min)

Vidéo :

- Les héros du Quotidien (2 min) *portail

Lectures :

- CSF (2018) : conseil du statut de la femme (mars 2018) – p.51 à 57
- Lavoie, Grand, Guberman, Andrieu (2003) : Les dispositifs d'action sur l'aide de l'entourage – p. 1 à 23
- Guberman et Lavoie (2012) : Politiques sociales, personnes âgées et PA – p. 61 à 70

Sites à connaître (à titre informatif) :

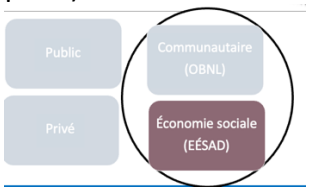
- https://www.211qc.ca/
- https://www.apacn.org/
- https://cpaq.org/
- https://www.lappui.org/fr/repertoire-des-ressources/
- https://procheaidance.quebec/

Prestataires de services de soutien à domicile au Québec

4 secteurs impliqués dans le soutien à domicile

Public	• C'est le secteur gouvernemental, les employés sont les fonctionnaires de l'état.
	• CISSS : centre intégré de santé de services sociaux
	• CIUSS : centre intégré universitaire de santé de services sociaux
	  ○ Les CIUSS ont des universités autour où on y fait des recherches plus facilement (mission des ciusss de faire de la recherche)
	• CIUSS capitale national :
	  ○ Né le 1 avril 2015 au moment de la fusion.
	  ○ 11 établissements publics ont été fusionnés

Privé	• C'est des agences privés, soit des entreprises à but lucratif qui font des affaires dans le milieu de la santé des services sociaux. • Ex. : agences de placement en soins infirmiers (infirmier, infirmier auxiliaire, des préposés au bénéficiaires, auxiliaires familiales et sociales, préposés) • Les agences envoient du personnels dans les familles qui en font la demande, soit dans les CLSC, soit dans les hôpitaux, ou dans les CHSLD qui manquent de personnel.

	○ Ils sont payé moins cher que ceux qui travaillent dans le secteur public • Le client doit payer pour recevoir les services d'une agence privé
Communautaire (OBNL : organisme à but non lucratif)	• Tous les organismes communautaires (OSBL : organisme sans but lucratif, mais maintenant c'est OBNL) • Grande quantité dans le domaine de la PA et dans toutes les problématiques ○ Société Alzheimer de QC ○ Carrefour des PA de QC ○ La Boussole ○ Centre Bonne entente ○ Albatros ○ Centre de prévention suicide de QC ○ … • Ces organismes offrent des services gratuit aux membres de la communauté, sont très accessible et généralement pas de liste d'attente. • Certains organismes fonctionnent avec des bénévoles, d'autres ont aussi des intervenants professionnels.
Économie sociale (EÉSAD : entreprise d'économie sociale en aide à domicile)	• Il est parfois mis dans la même catégorie que le communautaire • Ensemble ils sont appelé : le tier secteur (soit 3e après le public et le privé)  • Le secteur de l'économie sociale comporte quelques différences à celui du communautaire. ○ Le secteur ou les entreprises d'économie social en aide à domicile sont des entreprises entre le privé et le communautaire. Ce sont des OBNL (sans but lucratif) mais qui offrent des services qui sont payant (contrairement aux organismes communautaires). ○ Le secteur public défrais une partie des frais/coûts, mais l'aidé ou l'aidant doit assurer une part du coût selon ses revenus • **Lors de la création (1996) de EESAD :** voulait dire entreprise économie sociale en aide domestique ○ Ils offraient à l'époque slm des services d'entretien ménager et de l'aide à la vie domestique (AVD). • **Maintenant EESAD veut dire :** entreprise économie sociale en aide à domicile ○ Même acronyme, mais on change de nom, donc on change de mission. ○ ***Mission actuelle :*** offre des services d'hygiène, des soins personnels, des services qui relevaient avant du secteur public, ○ Intervient maintenant dans les AVQ (activité vie quotidienne) et plus slm dans les AVD (activité vie domestique) ce qui nécessite

	un autre niveau de formation (faire du ménage vs laver qqun n'est pas le mm niveau de tâche)

Services spécifiques aux personnes nécessitant du soutien à domicile

- Services qui sont théoriquement disponible pour tous les QC, mais la réalité est parfois différente.
  - L'accès aux services n'est pas le même partout.
- Le système est d'abord fondé sur les besoins de l'aidé. Les services au PA sont arrivé plus tard et sont offerts par les organismes communautaires ou les EESAD.
  - Le secteur public (CISSS, CIUSSS) s'est désengagé de ces services, même s'il en assume en parti le contrôle et le financement.
- Au CAN (ESG, 2012) :
  - 8% de la population de 15 ans et + a reçu une forme X d'aide à domicile pour un problème de santé de longue durée, une incapacité ou besoin lié au vieillissement
  - Quand les personnes sont plus jeunes, ce sont les problèmes de santé mental qui sont les raisons les plus fréquentes pour avoir recours à de l'aide à domicile.
  - Chez les personnes plus âgées, ce sont les besoins liés au vieillissement.
  - Ce sont les ainés comptant le groupe de plus grand nbr de personne bénéficiaire de service à domicile.
- Au QC, les soins et services à domicile sont dispensés par le réseau public (CISSS, CIUSSS) et le tier secteur
  - Les services sont rendus par de nombreux intervenants œuvrant dans différents milieux.
  - C'est le ministère de la santé et service sociaux qui demeure l'instance centrale qui définit des grandes orientations et décide de la répartition des ressources.
- Le secteur privé est particulier, car il peut œuvrer en marge de la société.

Proportion de personnes ayant reçu au moins 1 soin ou service à domicile selon l'âge (18 ans et plus, QC, 2013-2014)

Tableau 1
Proportion de personnes ayant reçu au moins un soin ou service à domicile[1,2] selon l'âge, population de 18 ans et plus, Québec, 2013-2014

	%
Sexe	
Hommes	4,6[a]
Femmes	8,5[a]
Âge	
18-44 ans	3,9[a]
45-64 ans	4,5[b]
65-74 ans	8,9[ab]
75 ans et plus	27,6[ab]
Ensemble du Québec	**6,5**

- 6.5 % QC ont des services à domicile (donc tous les autres QC en ont pas de besoin) donc c'est peu.
- 8.5 % des femmes
- **Répartition inégale selon l'âge :** Ce sont les ainés qui recevaient plus d'aide à domicile et cela est expliquer pcq la liste des services s'applique plus aux ainés + pcq le vieillissement occasionne des problèmes d'autonomie qui demande plus de soutien.
- **Presque les ¾ des ainés n'ont pas besoin d'aide :**

- Donc ne pas dire que les ainés coutent plus cher au réseau de la santé. On a prouvé que ce qui coute cher, ce sont les salaires faramineux des médecins et la nouvelle technologie (utilisé pour des maladies aigues et des accidents qui concerne peu les personnes âgés).
    - Source: Statistiques Canada. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013-2014, fichier de partage*. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec cité par Baraldi (2016), p.3.

Soins et services publics de soutien à domicile (SAD) au Québec (MSSS, 2003)

- Destinés aux personnes ayant de la difficulté à accomplir leur activité de la vie courante en raison d'une perte d'autonomie ou ayant un handicap physique ou une déficience intellectuelle. (donc pas aux PA)

4 Catégories de services	Ce qu'ils comprennent
1. Soins et services professionnels	• **Quoi :** ○ soins médicaux et infirmiers ○ services de nutrition ○ services de réadaptation de base ou spécialisés (physiothérapie/ ergothérapie/ orthothérapie/ audiologie) ○ services d'inhalothérapie ○ services psychosociaux ○ consultation: psychogériatrie, gériatrie, psychiatrie et pédiatrie Tous ces services sont normalement offerts par le **réseau public (CIUSSS)** • délais long, accessible restreinte en raison de contrainte de critères d'admissibilité/d'horaire/pénurie de main d'œuvre (manque d'infirmière, de physio) • services psychosociales les délais sont long et tlm ne peut pas payé pour ce service. • Une fois qu'on y a accès la qualité des services est très bonne • Ces services sont offert à la personne en perte d'autonomie pour son maintien à domicile et NON pour le PA (il en bénéficie de façon indirecte)
2. Services d'aide à domicile	• **Quoi :** ○ assistance personnelle (soins d'hygiène et l'aide à l'alimentation) ○ aide domestique (entretien ménager, lessive, préparation des repas) ○ soutien civique (aide pour établir un budget ou remplir des formulaires) ○ popote roulante ○ assistance à l'apprentissage (soutien aux activités personnelles et domestiques, aux activités de réadaptation, d'entraînement et de stimulation) ○ appui aux tâches familiales (soin des enfants, aide aux devoirs et aide à l'organisation matérielle). • Tous ces services sont offerts par le **réseau public,** les **OBNL** ou les **EÉSAD**

	• Il y a 30 ans, ces services étaient offert par le réseau public et le CLSC. Mais depuis fin 1980, il y a un désengagement de l'État dans ce secteur.
	• Besoins d'aides sont évalués par le réseau public (TS ou infirmière du CIUSS) qui ensuite réfère aux organismes communautaires ou EESAD ou au privé.
	• Le public offre de moins en moins de services dans la catégorie de soin à domicile et le secteur privé a pris plus de place.
	  ○ Donc c'est plus rapide pour une personne de recourir au privé, mais c'est $.
	  ○ Mais la qualité des services n'est pas tjrs garanties comme leur but premier est de faire de l'argent. (ce qui n'est pas le cas dans le public).
	  ○ Ces entreprises payent moins cher les employés que ceux dans le public, c'est donc plus dure de trouver ou garder ces employés compétents (qui préfèrent être mieux payé dans le public).
	  ○ Si les services sont inadéquats au privé, il y est plus difficile d'avoir des recours.
	• Depuis 1990, avec le virage ambulatoire, les politiques de déficits 0 des gouvernements, les coupures budgétaires = l'état en fait de moins en moins dans le domaine de l'aide à domicile. L'état a gardé la prestation des soins et services professionnels, mais a transféré la prestation des services à domicile aux OBNL, EESAD.

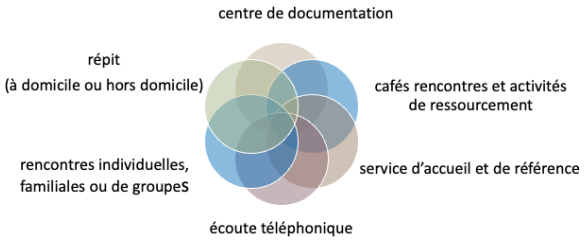
3. Soutien technique	• **Quoi :** ○ attribution de fournitures médicales et spécialisées, d'équipements et d'aides techniques. Tous ces services sont offerts par le **réseau public,** les **OBNL** ou les **EÉSAD**

4. Services aux proches aidants	• **Quoi :**
	  ○ gardiennage ou présence-surveillance (répit à domicile)
	  ○ répit (centre de jour, hébergement temporaire, répit hors domicile)
	  ○ dépannage (services d'urgence)
	  ○ appui aux tâches quotidiennes (soins des enfants, soutien dans l'organisation de la vie matérielle et l'accompagnement)
	  ○ services psychosociaux.
	Tous ces services sont offerts par le **réseau public à travers** les **OBNL** ou **EÉSAD**

Services offerts par les OBNL

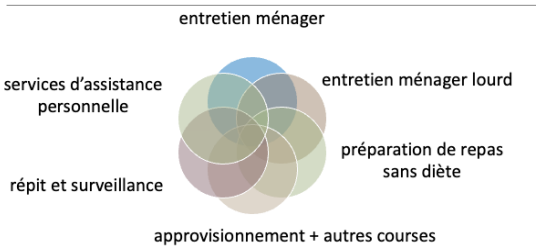
- Gratuit
- Pas ou peu de délais d'attente
- Offre variable d'une région à l'autre
- Offre des services aux aidants ex. Le carrefour des PA de QC

- Il existe aussi des organismes qui viennent en aide aux aidants selon la problématique de leur aidé ex. La société Alzheimer de QC, Parkinson QC, organisme pour le cancer/diabète
- **Pas besoin de référence pour y accéder, on appel directement**
    - Exception de certains services de répit qui sont financer par d'autres organismes
    - C'est l'appui pour les proches aidants d'aînés qui finance plusieurs de ses services depuis la loi 6 (''loi sur les fonds de soutien aux PA)
- **6 catégories de services offert par les OBNL :**
    - Rencontre individuelles, familiales ou de groupe
        - Ce sont des interventions psychosociales de +- long terme
        - En groupe, ce sont des groupes de soutien, d'entraide, psychoéducatif et différents les uns des autres. Il répond au besoin d'information des PA et au besoin de soutien social.
        - Les groupes permettent aux PA de partager leurs expériences, de voir qu'ils ne sont pas les seuls à vivre cette situation, ils apprennent de l'expérience des autres.
        - Certains groupes ciblent des PA particuliers ex. groupe d'homme, pour les PA qui travaillent, parent PA, …
        - Sont donné par les OBNL
    - Répit à domicile
        - Autrefois appelé gardiennage
        - Donné par des OBNL, EESAD, public (répit domicile, hors domicile)
        - Période de 2 à 4 heures par semaine **(court terme)**
        - Certains répit s'offrent 4 à 14 jours consécutif **(long terme).**
        - Renommé comme présence surveillance en 2003 dans la politique de soutien à domicile pour ce qui concerne les aînés
        - Le terme gardiennage est encore utilisé pour le répit donné à des enfants à besoins particulier
        - Avant c'était quelqu'un du CLSC, maintenant c'est quelqu'un d'un OBNL ou EESAD.
        - Cette personne vient à la maison pendant quelques heures pour s'occuper de l'aidé pendant que l'aidant peut se reposer ailleurs qu'à la maison. Mais dans les faits les aidants en profites pour travailler, aller à la banque, à l'épicerie.
        - La réalité est telle que certains aidants non pas de moyens de transport ou un budget transport, non pas d'endroit où aller, sont trop fatigué pour sortir, alors l'aidant reste à la maison lors du répit. Ex. Une aînée qui s'occupe de son mari, elle doit sortir lorsque la préposé offre du répit mais c'est l'hiver, donc ça rend la chose complexe pour une dame de 80 ans.
    - Répit hors domicile
        - Certaines personnes n'aiment pas que quelqu'un vienne garder leur proche pendants leur absence à la maison.
        - **2 types :** centre de jour et hébergement temporaire
        - **Centre de jour :** c'est une journée d'activité, de stimulation pour l'aidé, il y a parfois un transport offert mais sinon c'est l'aidant qui doit conduire. L'aidant peut donc rester seul chez lui. Service peu flexible (ex. mercredi pm activité x)
        - **Hébergement temporaire :** consiste à héberger l'aidé pendant quelques jours. Il faut réservé ça longtemps d'avance (prévoir le répit). Certains se font en état d'urgence (ex. si la PA est à l'hôpital).
    - Centre de documentation
    - Cafés rencontres et activités de ressourcement
    - Service d'accueilet de référence
    - Écoute téléphonique



Services offerts par les EÉSAD

- Répit peut être donné par les EESAD, OBNL, public
- 100 entreprises EESAD au QC dans 17 régions différentes, offre à 100 000/ an usagers, emploie 8 700 préposés
- Cout des services des EESAD entre 20-30 $ heure. Grâce programme d'exoration financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) du ministère de la santé et des services sociaux il est possible d'utiliser les services à moindre cout car l'État paie le reste.
- **6 catégories de services offert par les EESAD :**
    - Entretien ménager
    - Entretien ménager lourd
        - Ex. lavage mur, fenêtre
    - Services d'assistance personnelle
        - Ex. soins hygiène, toilette partielle, laver dent
    - Répit et surveillance
    - Préparation de repas sans diète
    - Approvisionnement et autres courses
        - Ex. Épicerie, banque, pharmacie
- 7 catégories de EESAD au QC.



Proportion de personne ayant reçu au moins un soin ou service à domicile selon la provenance, le sexe et l'âge (18 ans et plus, QC, 2013-2014)

- **La majorité de l'aide provient en 1er du gouvernement, 2e de l'entourage et puis 3e services privés.**
- L'aide peut être reçu par 2 sources différentes.
- Inclus dans l'aide gouvernementale : OBNL, EESAD,
    - Cela augmente le % d'aide gouv.
- Bcp d'aide de l'entourage n'est pas comptabilisé pcq on ne reconnaît pas que c'est de l'aide (''naturel'')

Proportion de personnes ayant reçu au moins un soin ou service à domicile[1] selon la provenance[2], le sexe et l'âge, population de 18 ans et plus, Québec, 2013-2014

	Aide gouvernementale	Aide d'agence privée	Aide de l'entourage ou bénévole
		%	
Sexe			
Hommes	2,5[a]	0,9[a]	1,6[a]
Femmes	4,2[a]	1,9[a]	3,7[a]
Âge			
18-44 ans	1,9[a]	0,8*[a]	1,3*[ab]
45-64 ans	1,8[b]	0,9*[b]	2,4[a]
65-74 ans	4,8[ab]	2,3*[ab]	3,3[b]
75 ans et plus	17,1[ab]	6,4[ab]	11,1[ab]
Ensemble du Québec	**3,4**	**1,4**	**2,7**

- Source: Statistiques Canada. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013-2014, fichier de partage*. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec cité par Baraldi (2016), p.4.

Questions de réflexions

- On a vu les besoins des proches aidants.
- On a vu les services offerts.

- **Pourquoi les services conçus pour répondre aux besoins sont-ils si peu utilisés?**
  - Les services sont peu connu par la population
  - Les services ne sont pas assez publicisé, on ne les voit pas à la télévision/radio/réseau sociaux
  - On ne fait pas d'offre active de services, autrement dit on attend que les gens demande. Donc s'ils ne demandent pas, on n'offre pas de service. Et quand c'est demandé, ça doit être fait clairement (on ne devine pas).
    - Ex. J'ai besoin d'aide, ok de quoi avez-vous besoin, euhh j'ai de la misère à nommer mon besoin
  - Des critères d'admissibilités aux services restreintes leurs accès. (ex. il faut avoir telle maladie, tel âge, tel jour, tel heure, t'en de temps
  - Les services ne répondent pas tjrs aux besoins. On offre à tlm les mêmes services et ce peu importe les besoins exprimés.
    - C'est comme ça pcq les services sont conçus pour des organisations et les intervenants.
    - Ex. ils sont dispo le jour, la semaine entre 9-5
    - Ne sont pas en fonction des besoins réels qui sont souvent la nuit, les fds
    - On ne connaît pas bien les besoins et ou on en tiens pas compte.

Vidéo - Les héros du quotidien (2 min)

Les ressources disponibles (variétés)

1) **Le répit court terme :**

- quelques heures répits qui peuvent permettent à l'aidant d'aller faire son épicerie, aller faire des petites courses quotidienne

2) **Hébergement temporaire :**

- La personne atteinte ira en hébergement dans un endroit qui sera spécialisé pour lui, pendant que l'aidant pourra prendre du repos à la maison

3) **Les centres de jour :**

- Augmente le réseau sociale de la personne atteinte (activité agréable hors de son domicile) et pour l'aidant c'est du temps de répit.

Services pour les PA

- Il n'y en pas énormément, mais ils se développent de plus en plus.
- Il faut prendre les devants et téléphoner les ressources (notre CLSC, baluchon Alzheimer,…) pour obtenir de l'aide.
  - Les PA doivent faire l'apprentissage d'aller cherche de l'aide.

Aidante témoignage

- Très compliqué, elle a fait bcp de demandes et subventions au gouvernent.
- Elle se compte chanceuse d'avoir toutes ses capacités pour avoir entrepris les démarches.
- Elle mentionne que pour faire appel à tous les services qui sont offerts, ce n'est pas si facile que ça.
- 1er on appel au CLSC et ensuite les autres organisations. Comme souvent les aidants vivent une période plus difficile, ça leur fait beaucoup.

Régions et services

- Faire des recherches sur les services spécifiques à leurs régions via la pochette et des liens offerts sur le site internet (facilitant la recherche).

Références

Association des bibliothèques publiques du Québec. (2017). Proches aidants : documentation à l'intention des proches aidants. http://biblioaidants.ca/fr/cahier_proches_aidants.php

Baraldi, R. (2016). Coup d'œil sur les soins et services à domicile reçus par les aînés au Québec en 2013-20141 Série Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Institut de la statistique du Québec.

Guberman, N., & Lavoie, J. P. (2012). Politiques sociales, personnes âgées et proches aidant-es au Québec: Sexisme et exclusion. Canadian Woman Studies, 29(3), 61-70.

Lamontagne, J., Labbé, M. & Guilbeault, J. (2013). Portrait-diagnostic des services offerts aux proches aidants de la Capitale-Nationale. L'Appui pour les proches aidants Capitale-Nationale.

L'Appui pour les proches aidants d'aînés. (2016). 20 projets inspirants pour soutenir les proches aidants d'aînés au Québec.

Lavoie, J.-P., Grand, A., Guberman, N. & Andrieu, S. (2003). Les dispositifs d'action sur l'aide de l'entourage en France et au Québec. de la solidarité encouragée... à la solidarité obligée. Gérontologie et société, 26(107), 109-129.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (2003). Chez soi : le premier choix. La politique de soutien à domicile, Québec, gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2002/02-704-01.pdf